

37. IL CERVELLO PRATICO

DURATA : 13:08

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video, "Il Cervello Pratico", presenta un approccio biodinamico dettagliato incentrato sul cervello e sulla sua espansione. L'istruttore insegna come identificare i livelli di espansione nel paziente, esplorando strategie efficaci di rivitalizzazione, come il lavoro sul cuore e sugli assi digestivi. Segue un'esplorazione dei movimenti di flessione cefalica e pontina, con specifiche precauzioni da prendere durante il tocco. Concentrandosi sulla sensazione di espansione, i praticanti impareranno ad accompagnare il movimento di encefalizzazione, comprendendo il ritmo e la sincronicità legati all'embriologia biodinamica. Questa sessione è sia teorica che pratica, promettendo agli studenti una comprensione arricchita e competenze sviluppate per migliorare la loro pratica.

37. IL CERVELLO PRATICO: APPROCCIO BIODINAMICO

I. POSIZIONAMENTO INIZIALE E RICERCA DELL'ESPANSIONE

Mi posiziono sopra il paziente, specificamente a livello dell'**insula**. Le mie mani sono posizionate qui, i miei pollici si incrociano leggermente, e mi assicuro di avere un buon punto d'appoggio per i gomiti e i polsi sul lettino.

Il **tocco** è estremamente delicato. Cerco di percepire l'**espansione** del campo.

A. IDENTIFICARE LA MANCANZA DI ESPANSIONE

La primissima cosa da valutare è il livello di **espansione**. Se l'espansione è insufficiente e non vengo "respinto" a sufficienza, è un segno che qualcosa non va.

Spesso, ci si aspetta un'espansione immediata e forte, ma non è sempre così.

B. STRATEGIE DI RIDINAMIZZAZIONE IN CASO DI MANCANZA DI ESPANSIONE

Se l'espansione è insufficiente, diverse piste sono da esplorare per **ridinamizzare** il sistema:

- **Il cuore:** Alleggerire il cuore è spesso un approccio molto efficace.

- **Gli assi digestivi:** Lavorare sugli assi digestivi (mesenterici, mesarici) o sull'asse celiaco può portare l'espansione necessaria.
- **Il sacro e i peduncoli:** Risalire fino al sacro e ai livelli peduncolari può anche aiutare.

In generale, lavorare con il cuore o gli assi digestivi permette di ottenere risultati più rapidi ed efficaci.

II. IL MOVIMENTO DI FLESSIONE E L'ENCEFALIZZAZIONE

Una volta presente l'espansione, percepisco un'espansione seguita da un movimento di **flessione** in avanti. Questa è la flessione cefalica, che porta il cervello verso il cuore.

Dietro, devo percepire un movimento di **flessione cervicale**. Se percepisco un leggero deficit a questo livello, ciò indica la necessità di una correzione cervicale o strutturale.

A. LA FLESSIONE PONTINA E LA TELENCEFALIZZAZIONE

Mi concentro poi sui miei mignoli e cerco la **flessione pontina**. Il movimento scende.

Poi, appare una nuova espansione. A questo stadio, posso aprire la mano. Questo è l'inizio del processo di **telencefalizzazione**, che viene recuperato dal livello occipitale verso il livello temporale.

B. ERRORI COMUNI E PRECAUZIONI

La maggior parte degli errori si verifica quando si tocca direttamente il cervello. È imperativo non toccare il cervello se non si è "sotto questa frequenza".

- Mi posiziono sopra, senza toccare con i pollici, mantenendo una bella distanza.
- Creo un **fulcro** molto delicato con i pollici e un importante punto d'appoggio.

C. LA SENSAZIONE DI ESPANSIONE

Una buona espansione è percepita come un piano di calore e una sensazione di spinta delicata.

III. IL MOVIMENTO SEQUENZIALE E L'ACCOMPAGNAMENTO

Eseguo un movimento molto delicato. Non è ancora il mio "H-ponte insulare". Faccio il movimento di flessione in avanti. Il movimento scende bene, ma può partire leggermente in torsione (ad esempio, verso sinistra). Accompagno molto leggermente questa torsione.

A questo stadio, una piccola correzione può essere necessaria, potenzialmente a livello cardiaco. Ci può essere un momento in cui il movimento non è perfetto, ma non è grave.

A. DISCESA DELLA FLESSIONE E PIANO PONTINO

Mi dirigo poi verso la discesa della flessione, che il paziente deve sentire distintamente. Scende senza problemi.

Una volta stabilito ciò, passo al **piano pontino**. Anche qui, un piccolo intervento può essere richiesto.

B. IL PIANO TELENCEFALICO E L'ESPANSIONE ASCENDENTE

Dopo il piano pontino, riporto la mia attenzione sul **piano telencefalico**, l'abbozzo telencefalico. Il movimento deve venire verso di me. Osservo un'espansione.

Mi posiziono sull'"**Hitchman**": il movimento gira verso di me, si espande e sale.

C. IL GRANDE MOVIMENTO DI ENCEFALIZZAZIONE

Il movimento riparte, ridiscende e si esprime. Ridiscendo molto dolcemente nella grande flessione, il grande movimento dell'**encefalizzazione**. Recupero questo movimento a livello occipitale.

È cruciale accompagnare questo movimento, non imporlo. Si aspetta che si manifesti, poi lo si segue. Il movimento è già presente, come un "binario disegnato", con un ritmo particolare. Si riproduce solo il **pattern** esistente.

IV. LA COMPRENSIONE DEL RITMO E LA SINCRONICITÀ

Questo pattern non è riproducibile nel senso di un ciclo che si ripete periodicamente. È un sistema che è costantemente lì, una **scrittura nel corpo**. È l'essenza stessa dell'**embriologia biodinamica**: l'abbozzo delle strutture (orecchie, sistema oculare, placode ottico, ecc.) si forma secondo questo pattern.

Aggiungeremo elementi a questa comprensione, ma dopo aver afferrato questa linea guida.

A. COLLEGARE LE STRUTTURE EMERGENTI AL MOVIMENTO

Comprendere questo movimento permette di vedere come i **ventricoli** si formano, come la **dura madre** segue, come il **cranio** si sviluppa. Se qualcosa blocca (un livello che non conosco ancora), posso appoggiarmi alla mia conoscenza del timing e dei fenomeni sincroni.

Ad esempio, posso cercare un'**arteria** o un livello elettrico specificato. Il paziente potrà sentire ciò che accade.

B. L'IMPORTANZA DELLA DINAMICA CARDIACA

È essenziale conoscere bene la **dinamica** del cuore. A volte, l'espansione è più importante da un lato (ad esempio, a sinistra).

C. EVITARE L'INTELLETTUALIZZAZIONE ECCESSIVA

È importante non intellettualizzare eccessivamente la percezione. Un'eccessiva attività mentale può "mettere troppa elettricità nel sistema limbico" e nuocere alla percezione sottile.

V. CASO PRATICO: ANALISI DI UNA PERCEZIONE

Durante una valutazione:

- L'espansione è delicata, non completa. La flessione è buona ma manca di dinamizzazione.
- Il ritmo è variabile. Il movimento si sposta maggiormente su un binario a sinistra, con un rallentamento.
- A volte è difficile raggiungere il **lobo frontale** in profondità.

A. PROGRESSIONE DEL MOVIMENTO

Poi, si passa al sistema pontino, con un'ascensione del tubo del paziente. Divento punto d'appoggio, e ciò spinge. L'espulsione laterale, in particolare a destra, parte più forte.

Il paziente "recupera il pacchetto in basso". Dopo un inizio un po' lento, il movimento si riprende bene.

B. LA TESTIMONIANZA DEL PAZIENTE

Il paziente descrive un inizio difficile, come se fosse necessario "mettersi in moto", rilasciare una fissazione a sinistra che impediva l'espansione. La flessione iniziale era difficile.

Quando è stata stabilita una connessione, il sistema si è "sbloccato". Questo è paragonabile all'imparare a guidare una **Formula 1**: all'inizio si è maldestri, poi con l'apprendimento, funziona.

C. LE CHIAVI DELL'ACCOMPAGNAMENTO

- **Ambiente e spazio**: Lasciare respirare, far oscillare il movimento.
- **Progressività**: Entrare progressivamente e connettersi a questa "scrittura" del corpo.
- **Centratura dell'ascolto**: Centrare l'ascolto a livello del cervello, e se non "va", osservare altrove.

È una questione di **sincronicità**. Bisogna "crearsi un sincronismo" per trovare la parola giusta e lavorare con questa sincronicità.